TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐẾN TẦN SUẤT SỬ DỤNG VÀ CHI PHÍ TIỀN TÚI (OOP) CHO DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ GIỮA NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ



Presented By:

Nhóm 2

Nội dung:

Chương 9

THÀNH VIÊN



- Trương Nhật Duy
- Trần Phương Minh
- Phạm Thị Thảo Nguyên
- Trần Ngọc Quân

NỘI DUNG

1 Cơ sở lý thuyết

2 Tổng quan

3 Thực trạng ở Việt Nam

4 So sánh với thế giới

5 Kết luận







CƠ SỞ LÝ THUYẾT

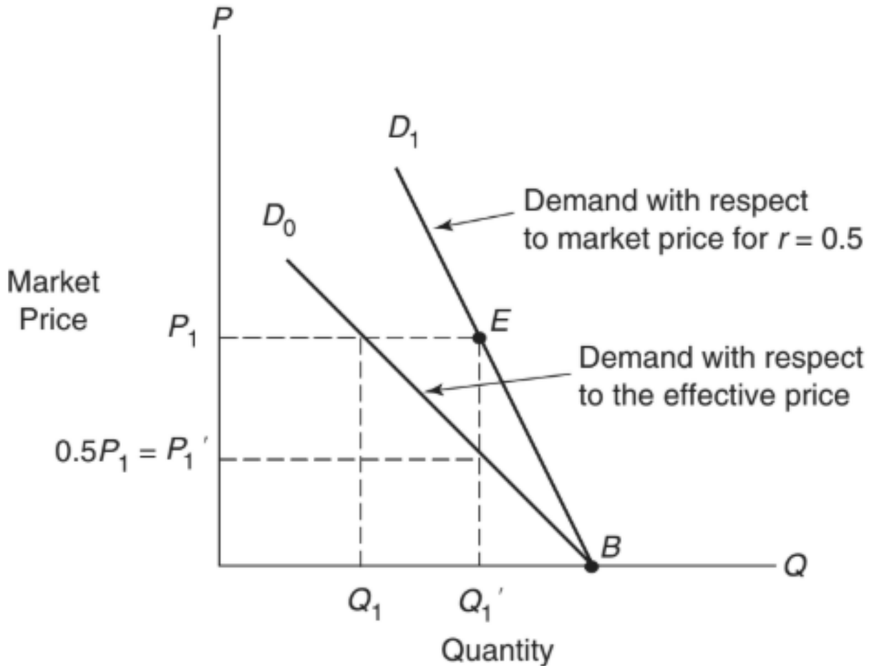
Theo lý thuyết cầu của Folland et al. (2013):

- Không có BHYT: Tại mức giá thị trường P1 (OOP) → tiêu thụ số lượng dịch vụ y tế Q1.
- Tham gia BHYT với tỷ lệ đồng chi trả r = a% → giá thực tế phải trả P1' = a% x P1 và tiêu thụ một lượng mới là Q1'. Hay nói cách, giờ đây, ở mức giá thị trường P1, người tiêu dùng đã tăng số lượng dịch vụ y tế sử dụng lên đến Q1'.

=> BHYT đã làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với dịch vụ y tế.

Ngoài ra, khu vực sống (nông thôn/thành thị) cũng được nhận định là một trong các yếu tố có tác động đến cầu dịch vụ y tế (Folland et al., 2013) → Ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của BHYT đối với cầu giữa hai nhóm.

Ví dụ, nghiên cứu của Erlyana et al. (2011) đã tìm thấy, ở Indonesia, khoảng cách từ nơi cư trú đến các cơ sở y tế gần nhất có tác động đáng kể và tiêu cực đến nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nhóm người sống ở nông thôn, nhưng chi phí khám chữa bệnh thì không → Nếu chỉ tập trung vào mở rộng độ bao phủ BHYT đối với nhóm này có thể sẽ không mang lại những cải thiện đáng kể.



Nguồn: 1. Folland, S., Goodman, A. C., & Stano, M. (2013). The economics of health and health care (7th ed.). Pearson.

2. Erlyana, E., Damrongplasit, K. K., & Melnick, G. (2011a). Expanding health insurance to increase health care utilization: Will it have different effects in rural vs. urban areas? Health Policy, 100(2–3), 273–281. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2010.11.008

MÔ TẢ VẤN ĐỀ

- Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng chi phí tiền túi (OOP) cao, chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu y tế, dẫn đến nguy cơ chi tiêu thảm họa cho hộ gia đình.
- Mặc dù tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế (BHYT) đã tăng mạnh (đạt khoảng 94% năm 2024), hiệu quả bảo vệ tài chính của nó vẫn còn gây tranh cãi.
- Có một thực trạng là người dân có xu hướng vượt tuyến, tập trung vào các bệnh viện tuyến cao, gây quá tải và tăng chi phí.
- Đặc biệt, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị về khả năng tiếp cận và gánh nặng tài chính vẫn rất lớn: người dân nông thôn có tần suất khám ngoại trú thấp hơn 3 lần so với thành thị và chịu áp lực lớn từ chi phí tự điều trị.

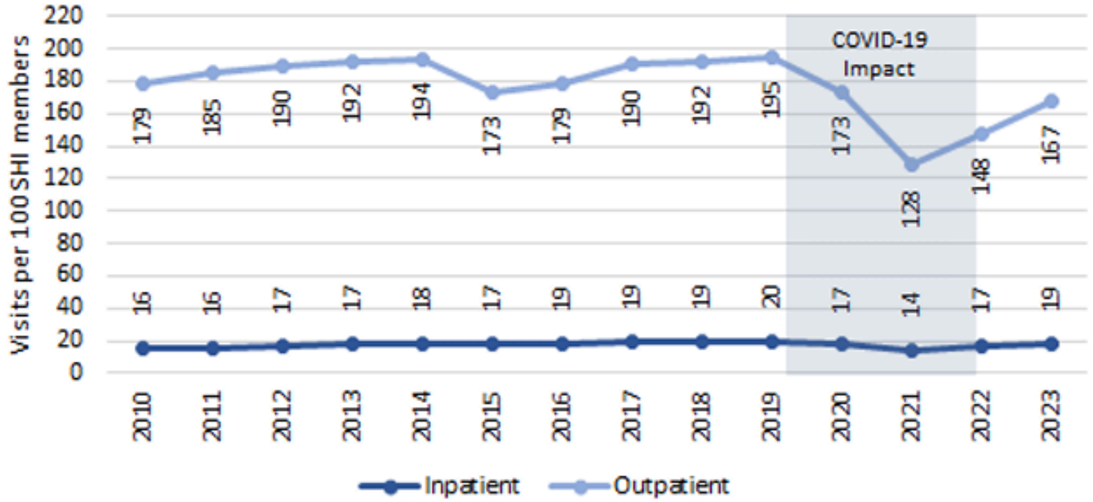
THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

Tác động của BHYT đến nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế

Nhìn chung, nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc điều trị của nhóm có BHYT ở cả khu vực nội trú và ngoại trú đều có xu hướng tăng nhẹ qua các năm

Nguồn: Bales, S., & Đào, L. H. (2023). Trends and differentials in household out-of-pocket spending for health in Viet Nam, 2010–2022 (Health, Nutrition, and Population Discussion Paper). World Bank. https://documents.worldbank.org/

Figure 3: Trends in Health Service Utilization Rates, Viet Nam Social Security Data, 2010–23



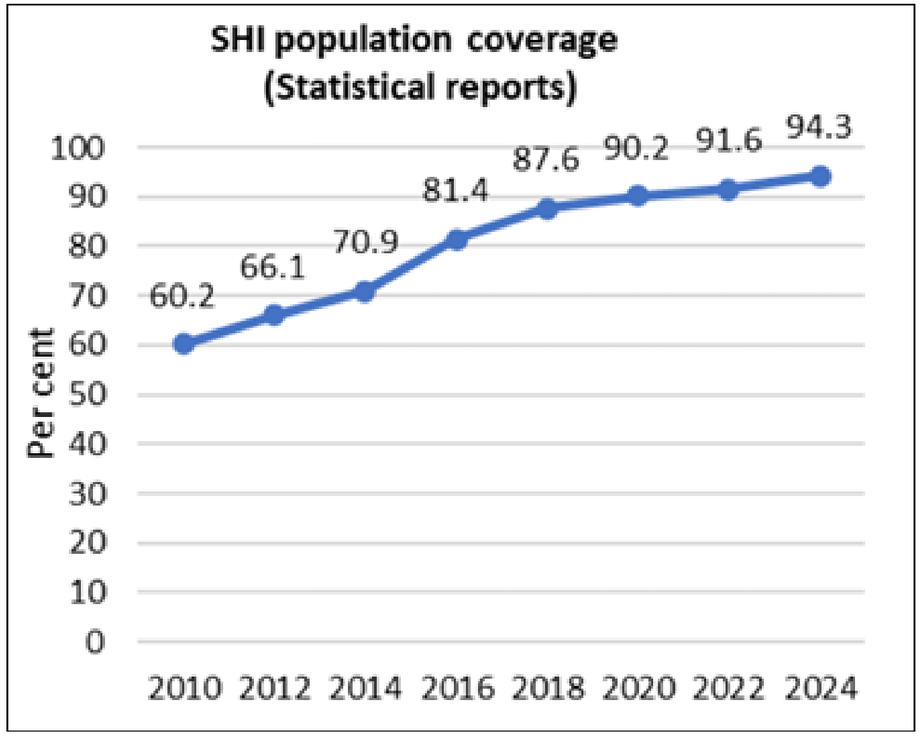
Outcome variable (in last 12 months)	Matching algorithm	VHI subsample		Heavily subsidised subsample	
		ATT	95% CI	ATT	95% CI
No of outpatient visits	NN	0.991*** (0.214)	0.629 to 1.639	1.289*** (0.266)	0.715 to 1.410
	Kernel	1.199*** (0.193)	0.843 to 1561	1.179*** (0.197)	0.830 to 1.704
	Radius	1.177*** (0.190)	0.750 to 1.629	1.173*** (0.196)	0.855 to 1.363
No of inpatient visits	NN	0.127*** (0.034)	0.035 to 0.269	0.156*** (0.058)	−0.014 to 0.271
	Kernel	0.107*** (0.037)	0.019 to 0.171	0.082* (0.045)	0.011 to 0.259
	Radius	0.106*** (0.036)	0.756 to 0.188	0.083* (0.044)	0.087 to 0.226

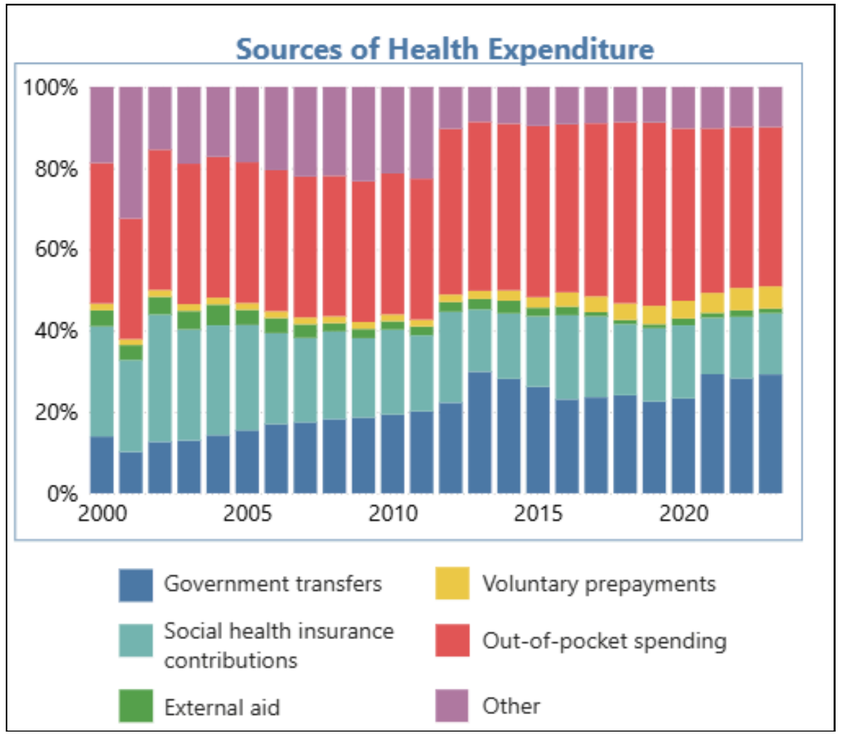
Dựa trên dữ liệu VHLSS 2014 và 2016, Thuong (2020) đã kết luận rằng BHYT làm tăng tuần suất sử dụng dich vụ y tế ở cả khu vực nội trú và ngoại trú của cả hai nhóm (nhóm VHI và nhóm heavily subsidised). Trong đó, phần lớn đối tượng thuộc nhóm heavily subsidised đến từ khu vực nông thôn (85.2%).

Nguồn: Thuong, N. T. (2020). Impact of health insurance on Healthcare Utilisation Patterns in Vietnam: A survey-based analysis with propensity score matching method. BMJ Open, 10(10). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-040062

THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

Tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi (OOP) cho dịch vụ y tế





Nguồn: Bales, S., & Đào, L. H. (2023). Trends and differentials in household out-of-pocket spending for health in Viet Nam, 2010–2022 (Health, Nutrition, and Population Discussion Paper). World Bank. https://documents.worldbank.org/

Nguồn: World Health Organization. (n.d.). Global Health Expenditure Database: Country health expenditure profiles. Retrieved January 23, 2026, from https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en?utm_source=chatgpt.com

Mặc dù tỷ lệ bao phủ BHYT xã hội đã đạt mức cao (chiếm 94.3% dân số năm 2024), tuy nhiên tỷ trọng chi tiêu trực tiếp từ tiền túi (OOP) cho y tế vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Tính đến năm 2023, OOP chiếm xấp xỉ 40% tổng chi tiêu y tế.

Tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi (OOP) cho dịch vụ y tế

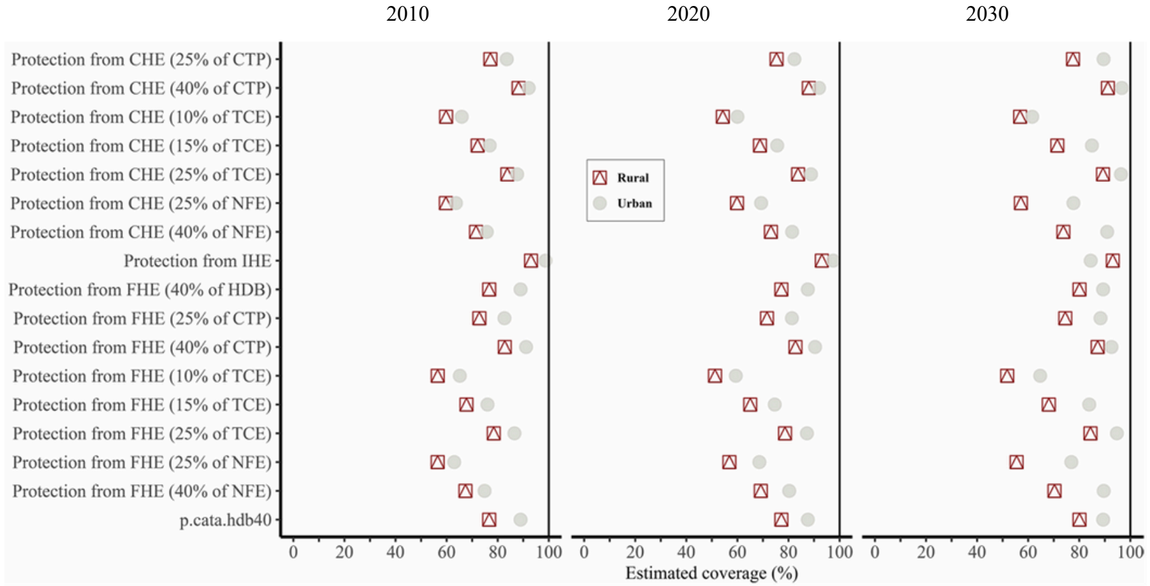


Figure 1. Observations and projections of Financial risk protection indicators in Vietnam by living area

Table 1 National coverage of financial risk protection in Vietnam from 2010–2030, and probability of achieving the 2030 targets

Indicators	Estimated coverage 2010–2020					Predicted coverage to 2030		
	Year 2010 (95% CI)	Year 2016 (95% CI)	Year 2020 (95% CI)	AAPC 2010–2016 (95% CI)	AAPC 2016–2020 (95% CI)	Year 2025 (95% CrI)	Year 2030 (95% CrI)	% reach target
Protection from CHE (25% of CTP)	79.1 (78.2 to 80.0)	75.1 (74.1 to 76.2)	78.1 (77.1 to 79.1)	-0.7 (-0.9 to -0.5)*	0.8 (0.5 to 1)*	81.4 (80.3 to 82.4)	84.3 (82.6 to 85.8)	0.0
Protection from CHE (40% of CTP)	89.4 (88.7 to 90.1)	86.8 (85.9 to 87.5)	89.6 (88.8 to 90.3)	-0.4 (-0.6 to -0.3)*	0.7 (0.5 to 0.9)*	92.2 (91.5 to 92.9)	94.2 (93.3 to 95.1)	4.5
Protection from CHE (10% of TCE)	61.7 (60.5 to 62.8)	56.7 (55.5 to 57.9)	56.6 (55.3 to 57.9)	-0.8 (-1.1 to -0.6)*	0 (-0.3 to 0.2)	58.5 (57.0 to 59.9)	60.8 (58.3 to 63.3)	0.0
Protection from CHE (15% of TCE)	73.6 (72.6 to 74.6)	70.0 (68.9 to 71.1)	71.5 (70.4 to 72.7)	-0.6 (-0.8 to -0.4)*	0.4 (0.1 to 0.6)*	75.0 (73.8 to 76.3)	78.7 (76.7 to 80.5)	0.0
Protection from CHE (25% of TCE)	85.0 (84.1 to 85.7)	82.7 (81.8 to 83.6)	85.8 (85.0 to 86.6)	-0.4 (-0.6 to -0.2)*	0.8 (0.6 to 1)*	89.9 (89.1 to 90.6)	93.2 (92.2 to 94.0)	0.0
Protection from CHE (25% of NFE)	60.9 (59.8 to 62.0)	61.8 (60.6 to 63.0)	63.6 (62.4 to 64.9)	0.2 (-0.1 to 0.4)	0.5 (0.2 to 0.7)*	65.9 (64.5 to 67.3)	68.0 (65.7 to 70.3)	0.0
Protection from CHE (40% of NFE)	72.8 (71.8 to 73.8)	73.3 (72.2 to 74.4)	76.5 (75.4 to 77.5)	0.1 (-0.1 to 0.3)	0.8 (0.5 to 1)*	80.0 (78.9 to 81.1)	83.1 (81.4 to 84.7)	0.0
Protection from IHE	94.8 (94.2 to 95.3)	93.3 (92.6 to 93.9)	94.9 (94.3 to 95.4)	-0.3 (-0.4 to -0.1)*	0.4 (0.3 to 0.5)*	95.4 (94.7 to 96.0)	95.5 (94.4 to 96.5)	83.6
Protection from FHE (40% of HDB)	80.5 (79.5 to 81.4)	77.3 (76.3 to 78.4)	81.4 (80.4 to 82.3)	-0.5 (-0.7 to -0.3)*	1 (0.8 to 1.2)*	84.6 (83.6 to 85.5)	87.0 (85.4 to 88.4)	0.0
Protection from FHE (25% of CTP)	75.8 (74.9 to 76.8)	71.5 (70.4 to 72.6)	75.5 (74.4 to 76.6)	-0.7 (-0.9 to -0.5)*	1 (0.7 to 1.2)*	79.5 (78.3 to 80.5)	82.8 (81.1 to 84.4)	0.0
Protection from FHE (40% of CTP)	85.3 (84.5 to 86.1)	82.0 (81.1 to 83.0)	85.8 (85.0 to 86.7)	-0.6 (-0.7 to -0.4)*	0.9 (0.7 to 1.2)*	89.0 (88.1 to 89.8)	91.3 (90.1 to 92.4)	0.0
Protection from FHE (10% of TCE)	59.2 (58.0 to 60.3)	53.9 (52.7 to 55.1)	54.5 (53.2 to 55.8)	-0.9 (-1.1 to -0.6)*	0.2 (-0.1 to 0.4)	56.8 (55.4 to 58.3)	59.6 (57.1 to 62.0)	0.0
Protection from FHE (15% of TCE)	70.3 (69.3 to 71.4)	66.2 (65.0 to 67.4)	68.9 (67.7 to 70.0)	-0.7 (-0.9 to -0.5)*	0.7 (0.4 to 0.9)*	73.1 (71.8 to 74.3)	77.2 (75.1 to 79.0)	0.0
Protection from FHE (25% of TCE)	80.9 (80.0 to 81.8)	77.9 (76.9 to 78.9)	82.1 (81.2 to 83.0)	-0.5 (-0.7 to -0.3)*	1 (0.8 to 1.3)*	86.8 (85.9 to 87.6)	90.5 (89.3 to 91.6)	0.0
Protection from FHE (25% of NFE)	58.5 (57.4 to 59.6)	58.9 (57.6 to 60.1)	61.6 (60.3 to 62.9)	0.1 (-0.2 to 0.3)	0.7 (0.4 to 1)*	64.7 (63.3 to 66.1)	67.7 (65.3 to 69.9)	0.0
Protection from FHE (40% of NFE)	69.7 (68.6 to 70.7)	69.5 (68.4 to 70.7)	73.6 (72.5 to 74.7)	0 (-0.2 to 0.2)	1 (0.8 to 1.3)*	77.8 (76.6 to 78.9)	81.3 (79.5 to 83.0)	0.0

Nguyen & Le (2025), sử dụng dữ liệu VHLSS các năm 2010, 2016 và 2020, nhận định rằng trong năm 2020, ở cấp độ quốc gia, tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình không rơi và khó khăn tài chính do chi tiêu y tế tương đối thấp (dao động từ 59.6% - 85.8%). Đến năm 2030, con số này được dự đoán tăng lên 59.6% - 91.3%. Ngoài ra, các chỉ số này có sự cách biệt đáng kể giữa khu vực nông thôn và thành thị.

Nguồn: Nguyen, P. T., & Le, P. M. (2025). Progress and inequalities in financial risk protection toward Universal Health Coverage: Insights from Vietnam. International Journal for Equity in Health, 24(1). https://doi.org/10.1186/s12939-025-02659-0

Tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi (OOP) cho dịch vụ y tế



Lee et al. BMC Health Services Research (2019) 19:318
https://doi.org/10.1186/s12913-019-4115-0

BMC Health Services Research

RESEARCH ARTICLE Open Access

Use of high-level health facilities and catastrophic expenditure in Vietnam: can health insurance moderate this relationship?

Hwa-Young Lee[1,2], Juhwan Oh[1*], Hoang Van Minh[3], J. Robin Moon[4] and S. V. Subramanian[5,6]

Abstract

Background: Overcrowding of high-level health facilities is a major concern in a Vietnamese health system. This may increase an economic burden to the households since health insurance is still insufficient in providing financial risk protection. This paper sought to examine the association between the use of high-level health facilities and household-level expenditure status such as out-of-pocket (OOP), and catastrophic expenditure on health, as well as a moderating effect of health insurances in rural and urban districts of Vietnam.

Methods: Data utilized a health system community survey collected between 2015 and 2017 in two districts of Vietnam (one from rural area in northern part, and the other one from urban area in sourthern part). The world Health Organization's definition of catastrophic expenditure was used. Multivariate tobit and logistic regression were employed for catastrophic expenditure and OOP respectively. Interaction term between health insurance status and visit frequency in high-level facilities was included to investigate the moderating effect of health insurance.

Nghiên cứu của Lee et al. (2019), sử dụng dữ liệu huyện Quốc Oai (nông thôn) năm 2015 và dữ liệu thị xã Thuận An (thành thị) năm 2017, cho thấy, BHYT không có tác động đáng kể đến OOP và CHE ở cả hai khu vực này. Tuy nhiên, ở huyện Quốc Oai, so với những hộ gia đình không tham gia BHYT, những hộ gia đình có ít nhất một người tham gia BHYT sẽ có khả năng phát sinh chi tiêu y tế thảm họa thấp hơn khi sử dụng các cơ sở y tế tuyến trên là 0.68 lần.

Nguồn: Lee, H.-Y., Oh, J., Hoang, V. M., Moon, J. R., & Subramanian, S. V. (2019). Use of high-level health facilities and catastrophic expenditure in Vietnam: Can health insurance moderate this relationship? BMC Health Services Research, 19(1). https://doi.org/10.1186/s12913-019-4115-0



Giang et al.
Health Research Policy and Systems 2022, 20(Suppl 1):112
https://doi.org/10.1186/s12961-022-00913-3

Health Research Policy and Systems

RESEARCH Open Access

Household financial burden associated with healthcare for older people in Viet Nam: a cross-sectional survey

Nguyen Hoang Giang*, Nguyen The Vinh, Hoang Thi Phuong, Nguyen Thi Thang and Tran Thi Mai Oanh

Abstract

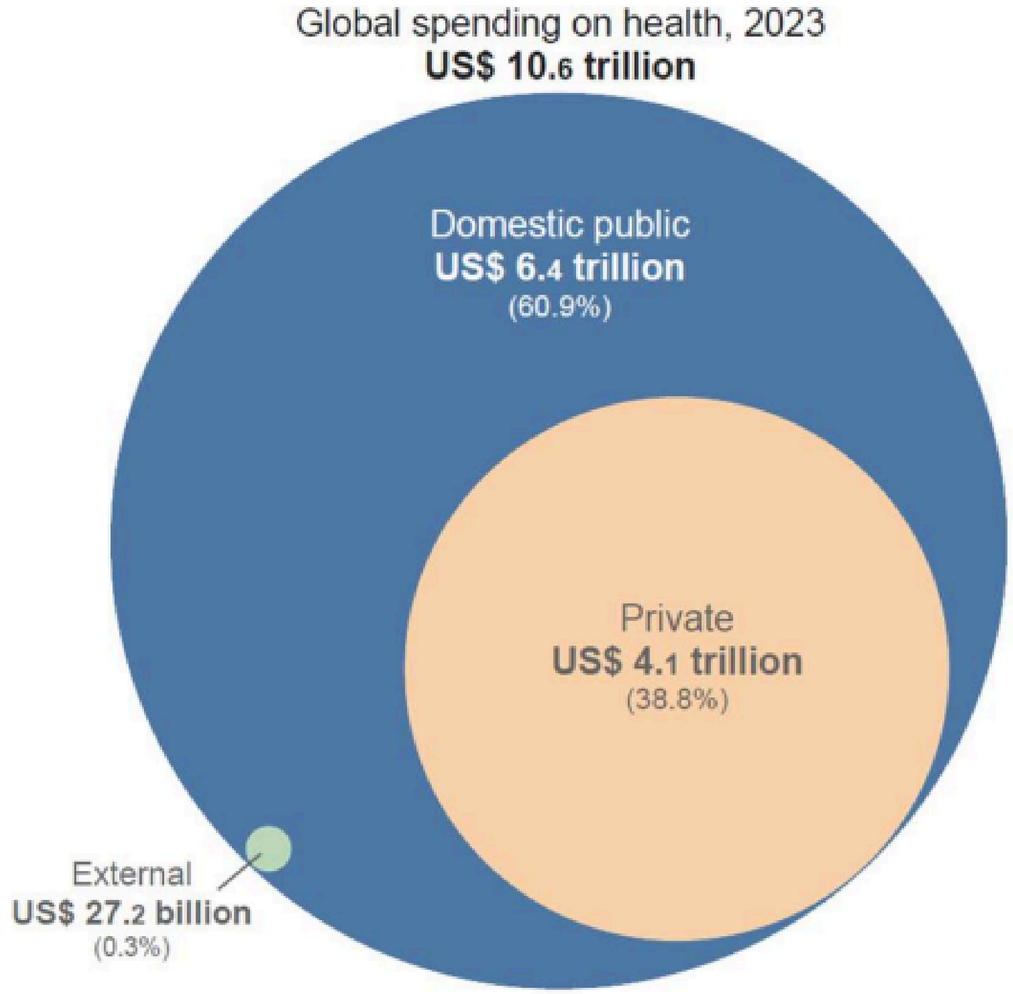
Background: Population ageing and the associated increase in the healthcare needs of older people are putting pressure on the healthcare system in Viet Nam. The country prioritizes healthcare for older people and has developed financial protection policies to mitigate financial hardship due to out-of-pocket health expenditures (OOPHEs) borne by their households. This study examines the level and determinants of the financial burden of OOPHE among households with people aged ≥ 60 years in Viet Nam.

Methods: A cross-sectional household survey was conducted among a sample of 1536 older people living in 1477 households in three provinces representing the North, Central and South regions of Viet Nam during 2019–2020. The financial outcomes were catastrophic health expenditure (CHE), using WHO's definition, and financial distress due to OOPHE. Multivariate binary logistic regression analysis was employed to determine the factors associated with these outcomes.

Nghiên cứu của (Giang et al., 2022) sử dụng dữ liệu khảo sát hộ gia đình từ năm 2019 - 2020 ở ba tỉnh Yên Bái, Thanh Hoá và Tiền Giang đã kết luận rằng BHYT không có tác động đáng kể đến chi tiêu y tế thảm họa (CHE) hay sự kiện khó khăn tài chính (là tình huống mà hộ gia đình phải vay tiền hay bán tài sản để chi trả cho dịch vụ y tế) ở những hộ gia đình có thành viên từ 60 tuổi trở lên.

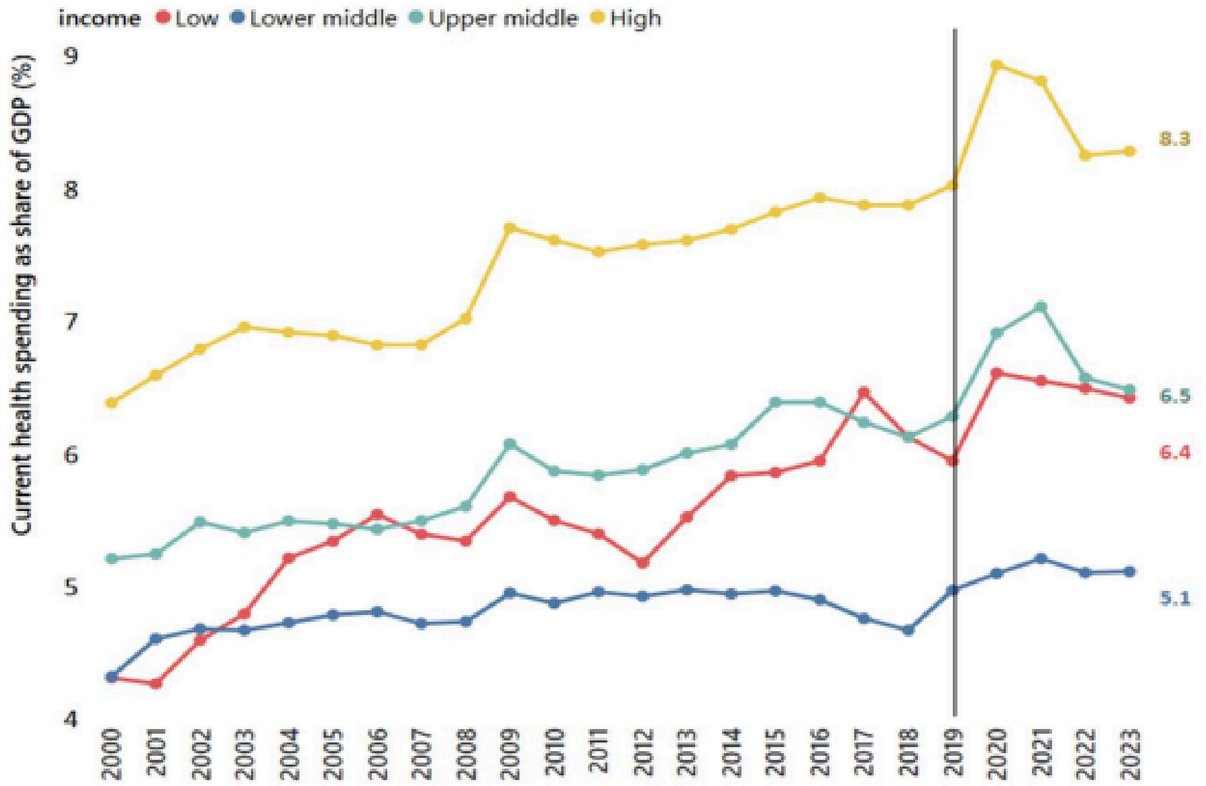
Nguồn: Giang, N. H., Vinh, N. T., Phuong, H. T., Thang, N. T., & Oanh, T. T. (2022). Household financial burden associated with healthcare for older people in Viet Nam: A cross-sectional survey. Health Research Policy and Systems, 20(S1). https://doi.org/10.1186/s12961-022-00913-3

- Tổng chi tiêu toàn cầu cho y tế đã đạt 10,6 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2023.
- Con số này chiếm 10% tổng GDP toàn cầu.



Data source: WHO Global Health Expenditure Database, 2025

Chi tiêu cho y tế tính theo tỷ lệ phần trăm GDP



Nguồn: WHO Global Health Expenditure Database, 2025

Các nước thu nhập cao luôn có tỷ trọng chi y tế trong GDP lớn nhất, trong khi các nước thu nhập thấp và trung bình thấp duy trì mức chi thấp hơn, cho thấy khoảng cách rõ rệt về năng lực tài chính cho y tế giữa các nhóm thu nhập.

Health Expenditure Profile

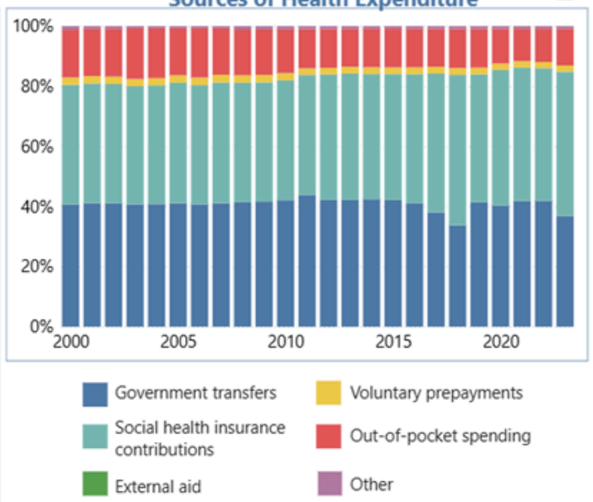
Japan

Select Country / territory: Japan

Key Statistics

	2005	2010	2015	2019	2023
Health spending US$ per capita (CHE)	2.893	4.072	3.754	4.431	3.638
Government domestic health spending % Health spending (GGHE-D%CHE)	81,2%	81,9%	84,1%	84,0%	84,8%
Out-of-pocket spending % Health spending (OOPS%CHE)	15,7%	14,6%	12,9%	12,9%	12,2%
Priority to health (GGHE-D%GGE)	17,8%	18,9%	23,2%	24,7%	23,3%
GDP US$ per capita	37.771	44.928	34.924	40.395	33.876

Sources of Health Expenditure



Thu nhập cao

- Nhật Bản: Chi tiêu y tế cao, tài trợ chủ yếu từ ngân sách và bảo hiểm → gánh nặng chi trả trực tiếp thấp.

Health Expenditure Profile

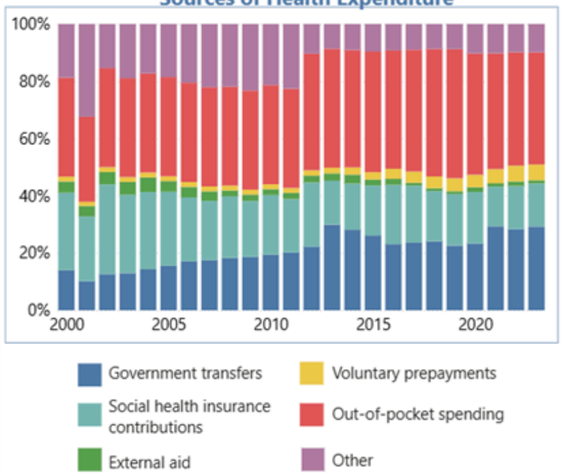
Viet Nam

Select Country / territory: Viet Nam

Key Statistics

	2005	2010	2015	2019	2023
Health spending US$ per capita (CHE)	39	85	121	171	197
Government domestic health spending % Health spending (GGHE-D%CHE)	41,4%	40,3%	43,6%	40,6%	44,3%
Out-of-pocket spending % Health spending (OOPS%CHE)	34,6%	34,7%	42,1%	45,1%	39,2%
Priority to health (GGHE-D%GGE)	8,7%	8,6%	8,5%	10,2%	10,5%
GDP US$ per capita	902	1.683	2.578	3.441	4.323

Sources of Health Expenditure



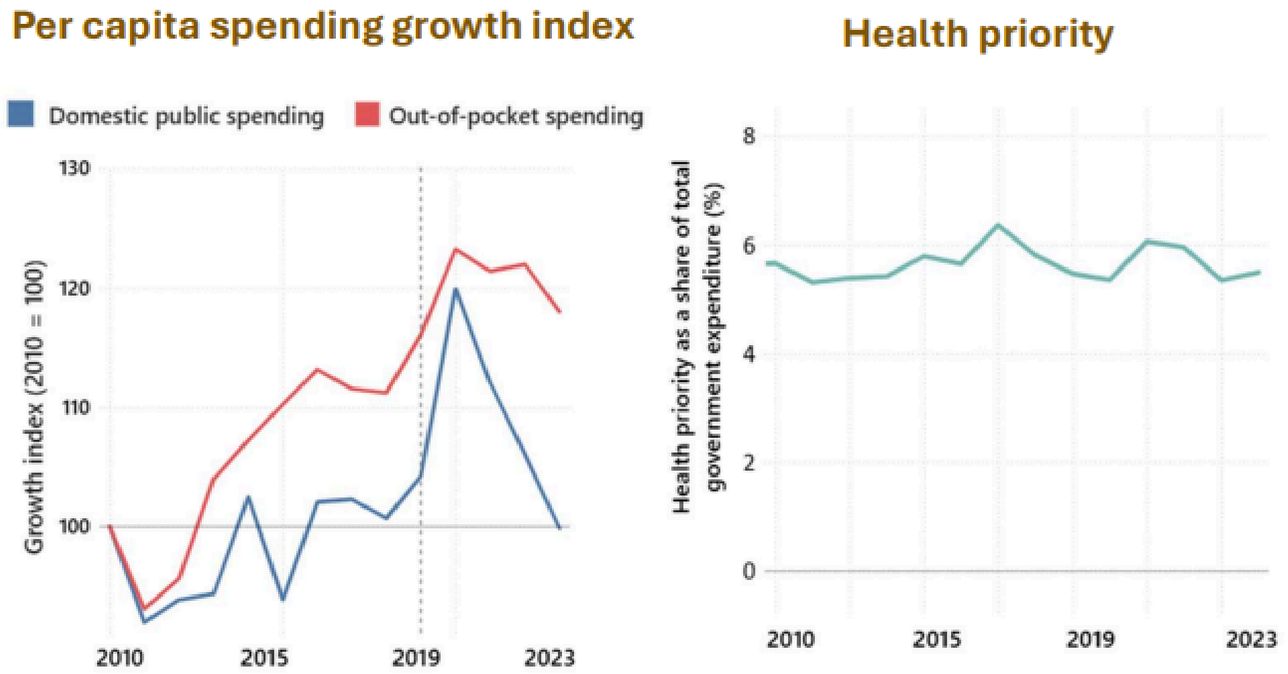
Thu nhập trung bình

- Việt Nam: Chi tiêu y tế thấp hơn, phụ thuộc nhiều vào chi trả trực tiếp → bảo vệ tài chính cho người dân còn hạn chế.

Chi tiêu y tế ở các nước thu nhập thấp tăng chủ yếu do người dân tự chi trả, trong khi tỷ trọng chi ngân sách cho y tế hầu như không đổi.

→ Phản ánh mức độ ưu tiên cho y tế vẫn còn hạn chế.

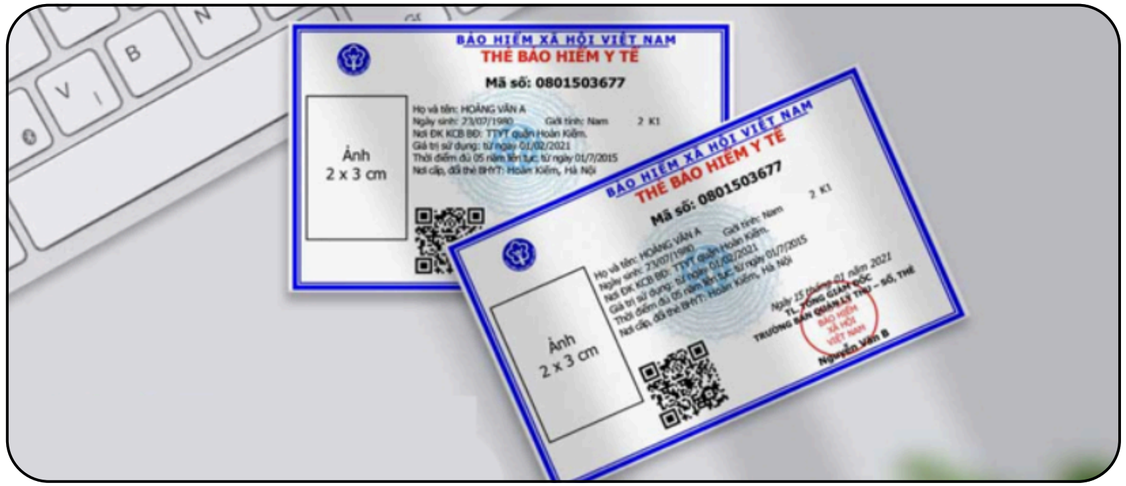
Health spending trend in low income countries



Data source: WHO Global Health Expenditure Database, 2025

KẾT LUẬN & HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Kết luận về hiệu quả bảo vệ tài chính của BHYT:
BHYT thực sự làm tăng nhu cầu sử dụng nhưng hiệu quả giảm chi phí OOP còn hạn chế do hành vi vượt tuyến và tự điều trị



1. Thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế Nông thôn - Thành thị

- **Nâng cao chất lượng y tế cơ sở:** Tập trung đầu tư nhân lực và thiết bị cho Trạm y tế xã và Bệnh viện huyện để giữ chân bệnh nhân tại địa phương, giảm chi phí cơ hội và chi phí đi lại cho người dân nông thôn
- **Hỗ trợ nhóm yếu thế:** Tiếp tục trợ cấp phí đóng BHYT và giảm mức đồng chi trả cho hộ nghèo, dân tộc thiểu số và những hộ có tỷ lệ phụ thuộc cao (người già, trẻ em).

2. Cải cách cơ chế tài chính và chi trả

- **Thay đổi phương thức thanh toán:** Chuyển từ phí dịch vụ sang “định suất" hoặc "theo nhóm chẩn đoán" để kiểm soát tình trạng lạm dụng chỉ định dịch vụ từ phía nhà cung cấp.
- · **Mở rộng "độ sâu" chi trả:** Bổ sung vào danh mục bảo hiểm các chi phí hiện đang chiếm tỷ trọng OOP cao như thuốc điều trị bệnh mãn tính tại nhà và các xét nghiệm kỹ thuật cao thiết yếu.

3. Quản lý hành vi người tiêu dùng và thị trường

- **Kiểm soát việc tự điều trị:** Có chính sách quản lý thị trường thuốc lẻ để giảm tỷ lệ người dân tự mua thuốc (self-treatment) không qua tư vấn chuyên môn, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí OOP tại nông thôn
- **Thiết kế mức đồng chi trả linh hoạt:** Áp dụng mức đồng chi trả thấp hơn cho việc khám chữa bệnh đúng tuyến tại cơ sở để định hướng hành vi sử dụng dịch vụ y tế hợp lý.

Thank You



Presented By:

Nhóm 2

Nội dung:

Chương 9